EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 72661
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-10-18 11:38:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: EVA DEL CARMEN COFRE SEPULVEDA			RUN	: 6.423.143-K
F.Nac	: 07-08-1950	Edad	: 73 AÑOS, 2 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: RIBERA NUBLE			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-10-06	Fecha Egreso	: 2023-10-18 11:38:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G40.4-OTRAS EPILEPSIAS Y SINDROMES EPILECTICOS GENERALIZADOS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Status convulsivo resuelto
-Epilepsia secundaria
-Antecedentes: AVE TACMD (antiguo), HTA, DM-2, insuficiencia aórtica, demencia tipo EA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. G40-EPILEPSIA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Ingresa el 06/10/23 por episodio de crisis TCG, habría presentado 8 eventos convulsivos sin recuperación de nivel de conciencia. En servicio de urgencias es intubada, se cargó 2 gramos de Levetiracetam y posterior BIC de Midazolam que se suspende en forma progresiva. Se extuba se mantiene estable en cuanto a lo neurológico, impresiona en su basal.
Cursando ITU y neumonia aspirativa en tratamiento antibiótico, y en corrección hidroelectrolítica.

Evolución
Paciente estacionaria en su condición general, HDN estable, RS al monitor, eupneica, afebril, tranquila y cooperadora, mantiene misma reactividad que días previos, no refiere molestias, sin nauseas ni vómitos, tolera bien alimentación. Sin crisis convulsivas.
Compleó tto ATB sin incidentes.
Exs imagenológicos seriados sin cambios respecto a los previos.
Exs lab destaca PCR baja, resto normal.
Mantiene régimen papilla por boca, agua por SNG. Durante KNTM logra bipedestación con 2 operadores.
Piramidalismo bilateral en regresión, paresia ESD en regresión.
Se decide no realizar RM hospitalizada, ayer no siguió instrucciones a pesar de sedación previa.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy, IC HODOM para continuar rehabilitación fonoaudiológica, mantener tto y control ambulatorio en policlínico de Neurología, se evaluará si es necesario realizar RM.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-IC HODOM para continuar rehabilitación fonoaudiológica
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología

INDICACIONES AL ALTA

1. -Losartan 50 mg c/12h

2. -Espironolactona 25 mg/d
3. -Levetiracetam (500 mg) 2 comp c/12h
4. -Bisoprolol (2.5 mg) 2 comp/d
5. -Furosemida (40 mg) 1/2 comp c/12h
6. -Amlodipino 10 mg/d
7. -Quetiapina 25 mg SOS si agitación o insomnio

EXÁMENES Y RESULTADOS

18/10/23
-Alb 3.9
-Crea 0.8 MDRD 70.31 Uremia 57
-Amilasa 166 Lipasa 218
-FA 151 BI 0.5 BD 0.1 BT 0.6 GOT 38 GPT 45 GGT 145
-CKMB 10 CK 157
-LDH 241
-PCR 26.1
-Na 144 K 3.6 Cl 110
-Leu 11300 Hb 10.8 Plaq 460000 Seg 75 VHS 56

16/10/23
-Crea 0.8 MDRD 70.31 Uremia 40
-FA 179 BI 0.4 BD 0.07 BT 0.47 GOT 52 GPT 60 GGT 165
-CK 125 CKMB 9
-PCR 13.8
-Na 144 K 3.9 Cl 109
-Leu 11700 Hb 11.3 Plaq 416000 Seg 73 VHS 36
-INR 1
-Procal 0.06

13/10/23
-Crea 0.9 MDRD 61.38 Uremia 62
-FA 197 BI 0.5 BD 0.05 BT 0.55 GOT 114 GPT 91 GGT 182
-CKMB 13 CK 333
-Lact 1
-PCR 25.8
-Na 142 K 3.8 Cl 107
-Leu 9800 Hb 11.5 Plaq 312000 Seg 68 VHS 39
-INR 1.02 TTPA 27
-Procal 0.26

2/10/23
-RPR N/R
-Alb 4.3 AU 4.5
-Crea 1 MDRD 54.35 Uremia 38
-FA 237 BI 0.5 BD 0.1 BT 0.6 GOT 161 GPT 80 GGT 131
-LDH 366
-Na 143 K 4 Cl 104
-PCR 30.2
-INR 0.96 TTPA 28
-Leu 12300 Hb 13 Plaq 323000 Seg 77 VHS 37
-Hb glic 5.4
-GSA pH 7.43 CO2 26.8 HCO3 17.8

10/10/23
-Glic 131
-Alb 3
-Crea 0.8 MDRD 70.31 Uremia 36
-Ca 9.1 Na 138 K 4.2 Cl 107
-CK 268
-LDH 195

-Lact 0.7
-PCR 86.1
-ProBNP 909
-Procal 2739
-GSA pH 7.43 CO2 35.2 HCO3 24

Ecocardiograma 08/10/2023:
Vi no dilatado geometria normal fevi conservada 67%, dilatación de la aorta ascendente de 4.5 cm, insuficiencia aórtica severa, insuficiencia mitral leve, crecimiento biauricular, sin ht pulmonar psap estimada: 32 mmhg.
Angiotac cerebral –cuello 08/10/2023
Normal trayecto y calibre de principales arterias cervicales e intracraneanas, no reconociendo segmentos irregulares o estenóticos ni imágenes que sugieran disección/mav u/o aneurismas. Placa ateromatosa calcificada en el origen de la carótida interna izquierda, no determina estenosis significativa. Adecuada representación de los principales senos venosos durales, sin signos de trombosis
Tac cerebral 06/10/2023
No signos de hemorragia aguda intracraneana. Focos de hipodensidad de sustancia blanca supratentorial de carácter microangiopático. Surcos de la convexidad aumentados de amplitud de forma difusa. Leve ventriculomegalia supratentorial, pasiva. Iii-iv ventriculo en línea media. Diferenciación de sustancia gris y blanca bien preservada. Secreciones otomastoideas derechas

OBSERVACIONES:

Ex fco general
-Perfusión e hidratación N, yug no ing a 30°
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+), SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico
-Mental: vigil, orientada parcialmente en espacio y tiempo, parcialmente atingente al medio, no invierte series simples, lenguaje hipofluente, nominación 3/3, repite frases cortas, comprende órdenes simples de 2 pasos, distingue derecha-izquierda sin cruzar linea media
-PC: CV por amenaza impresiona N, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, motilidad y sensibilidad algésica faciales N, hipofonia leve, disartria leve, nistagmo(-), pares bajos impresionan N
-Motor: ESD M4, ESI M4-5, EEII M4, espasticidad vs paratonía en las 4 EE, hiperreflexia en EEII y ROT vivos en EESS, RCP extensor bilateral, clonus(-)
-Sensitivo: algesia impresiona conservada en las 4 EE
-Cerebelo: diadococinesia impresiona N en EESS, resto n/e por inatención
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO